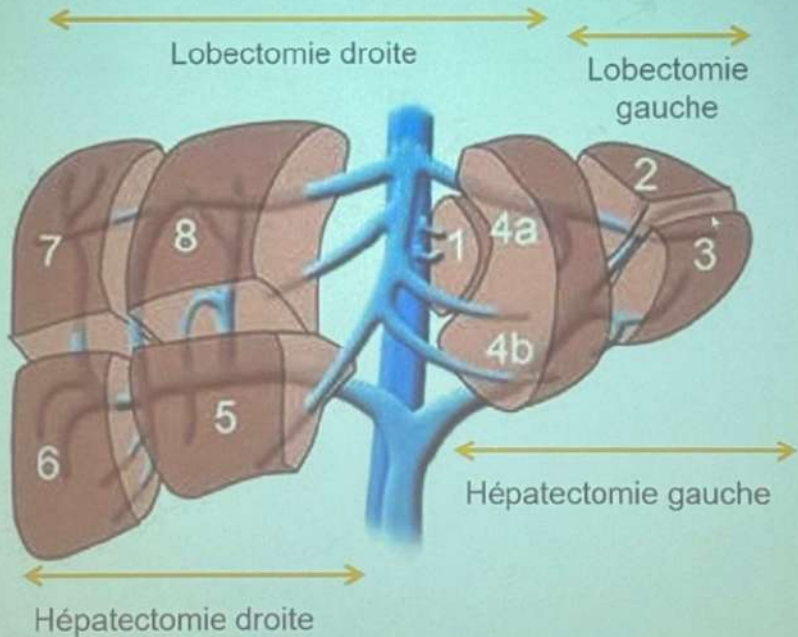


Quel est le signe pathognomonique d'une perforation gastrique ou colique ?

- A: Douleurs transfixantes atroces
- B: Vomissements
- C: Signes de choc
- D: Pneumopéritoine
- E: Arrêt du transit



Deux ans après une colectomie droite pour cancer, un patient de 65 ans présente une métastase du segment 3 du foie.
Quelle opération est adéquate?

- A: Lobectomie droite
- B: Lobectomie gauche
- C: Hépatectomie droite
- D: Hépatectomie gauche
- E: Transplantation

Un patient se présente avec une suspicion d'hépatite fulminante.
Quel test est adéquat pour juger de la fonction du foie?

A: ASAT

B: Plaquette

C: INR

D: Créatinine

E: Phosphatase alcaline

Un homme de 56 ans présente des douleurs de l'hypochondre droit continues depuis 24 heures. Il consulte aux urgences. On retrouve une défense de l'hypochondre droit. Son BMI est à 29 Kg/m². La température est à 37.6°. Les leucocytes sont à 13 G/l (norme: 4.5-11). Les tests hépatiques sont normaux. Une échographie montre une stéatose hépatique modérée avec des parois de la vésicule hypervasculaires à 5 mm. Il y a un signe de Murphy radiologique.

Quel est le diagnostic?

Long Menu

Un patient de 54 ans présente une lésion du segment 4 de 3 cm de diamètre. L'alpha-foetoprotéine est à 432 $\mu\text{mol/l}$. Il a une anamnèse d'infection au virus de l'hépatite B.

Quel est le diagnostic?

- A: Cirrhose
- B: Adénome
- C: Cholangiocarcinome
- D: Métastase de carcinome colo-rectal
- E: Carcinome hépato-cellulaire

Quel est le signe d'une pression veineuse portale élevée chez une patient avec cirrhose?

- A: Turgescence jugulaire
- B: ALAT élevées
- C: INR bas
- D: Thrombopénie
- E: Bilirubinémie élevée

Quel intervention est la plus adéquate?

A: Laparoscopie

B: Laparotomie

C: ERCP

D: Gastroskopie

E: Drainage per-cutané

Un patient de 76 se présente avec de douleurs de l'hypochondre droit, un ictère et de la fièvre. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A: Cholangite
- B: Pancréatite
- C: Gastrite
- D: Migration de calcul dans le cholédoque
- E: Cholécystite

Une femme de 25 ans présente une insuffisance rénale terminale. Elle est de groupe sanguin B.

Quel est le meilleur traitement?

A: dialyse péritonéale

B: transplantation d'un rein reçu d'une amie de 45 ans, de groupe sanguin 0

C: transplantation d'un rein reçu d'un donneur en mort cérébrale de 40 ans, de groupe sanguin B

D: transplantation d'un rein reçu de son mari de 35 ans, de groupe sanguin A

E: hémodialyse

Une femme de 65 ans bénéficie d'une coloscopie dans le cadre d'un bilan pour anémie spoliative. Cet examen découvre une masse sténosante du sigmoïde non franchissable par l'endoscope dont les biopsies diagnostiquent un adénocarcinome.

Que proposez-vous comme première démarche?

- A: sigmoïdectomie laparoscopique
- B: échographie abdominale
- C: radiothérapie néo-adjuvante
- D: CT scan thoraco-abdominal
- E: Hartmann

Un homme de 25 ans, BMI: 41 KG/m², arrive aux urgences pour blessure abdominale par pic à glace infligée 4h plus tôt. La plaie, sus-ombilicale, mesure 1 cm de large et est difficilement examinable en profondeur en raison du morphotype du patient. Le patient est normocarde, normotendu, eupnéique. Le bilan sanguin ne révèle pas de particularité.

Que proposez-vous?

- A: laparotomie
- B: CT scan abdominal
- C: exploration de la plaie sous anesthésie locale
- D: suture de plaie par des points séparés
- E: radiographie de l'abdomen sans préparation

Un informaticien de 45 ans se présente aux urgences avec des douleurs en coup de poignard de la région épigastrique, persistantes depuis 4 heures. Il est fumeur et admet avoir présenté occasionnellement des douleurs du haut abdomen depuis plusieurs semaines. Une ultrasonographie abdominale effectuée récemment était sans particularité, et ne montrant en particulier aucune évidence de cholélithiase. À l'examen clinique, vous constatez un abdomen aigu avec un péritonisme du haut abdomen et une absence de bruit. Dans ce contexte, quelle technique d'imagerie semble la plus utile?

- A: une radiographie de l'abdomen de face
- B: une radiographie du thorax de face couché
- C: une radiographie du thorax de face debout
- D: un transit baryté
- E: une ultrasonographie de nouveau

Un homme de 63 ans est admis aux urgences à cause de douleurs dans l'hypochondre droit. Il est dans un état général diminué, sa température est de 38.3 °C. A la palpation, il présente une douleur de l'hypochondre droit sans défense, ainsi qu'un ictère.

valeurs de laboratoire:

bilirubine 83 $\mu\text{mol/l}$ (norme 5.1-17.0 $\mu\text{mol/l}$)

ALAT 120 U/l (norme 0-35 U/l)

phosphatase alcaline 320 U/l (norme 30-120 U/l)

leucocytes 14 G/l (norme: 4.5-11)

neutrophiles 85 % (norme: 40-70)

L'échographie montre une lithiase vésiculaire, ainsi qu'une dilatation des voies biliaires intra- et extrahépatiques.

Quelle est la démarche correcte dans cette situation?

A: une antibiothérapie seule

B: une antibiothérapie et une cholécystectomie d'urgence

C: une antibiothérapie, une ERCP avec papillotomie, une cholécystectomie laparoscopique ultérieure

D: une antibiothérapie, un drainage endoscopique ou transhépatique sans cholécystectomie

E: une tomographie computerisée abdominale

Un joueur de football, âgé de 18 ans, entre en collision avec un co-équipier. Radiologiquement, on constate une fracture de la 10^{ème} côte gauche. Quatorze jours plus tard, il présente un collapsus à son poste de travail ; il est hospitalisé en état de choc.

La cause la plus probable est :

- A: Une hémorragie intracrânienne
- B: Un ulcère gastrique perforé
- C: Une rupture de la rate
- D: Une rupture du diaphragme
- E: Un pneumothorax sous tension

Un patient de 52 ans, japonais récemment établi en Suisse, présente depuis plusieurs mois des douleurs épigastriques accrues par la prise de nourriture, associées à une sensation de réplétion gastrique précoce depuis quelques semaines et de vomissements postprandiaux depuis 2 jours. Il signale également une perte pondérale de 5 kilogrammes en 1 mois.

Quel examen est le plus susceptible de poser le diagnostic?

A: une oesophago-gastro-duodénoscopie

B: une radiographie de l'abdomen à vide

C: un transit baryté

D: une tomodensitométrie abdominale (CT-scanner)

E: une imagerie par résonance magnétique (IRM)

Indications à la cholécystectomie:

- Lithiase vésiculaire symptomatique
- Complication de la lithiase vésiculaire:
 - Migration
 - Cholangite
 - Pancréatite biliaire
- Risque de cancer
 - Polype ($>2\text{cm}$)
 - Vésicule porcelaine

Une patiente de 40 ans, en bonne santé habituelle et sans plainte particulière, se présente à votre cabinet avec le résultat d'un bilan radiologique réalisé lors d'un check-up. Le rapport de l'échographie décrit de multiples calculs dans la vésicule biliaire. Ils sont visibles sur la radiographie de l'abdomen.

Comment poursuivez-vous la prise en charge de cette patiente ?

- A: Cholécystectomie laparoscopique
- B: Absence de traitement
- C: Suivi par échographie dans une année
- D: Lithotripsie
- E: Prescription d'acide ursodésoxycholique

Un patient de 68 ans a un ictère nu et présente un signe de Courvoisier.
Quel est le diagnostic le plus probable?

A: Cholangite

B: Cirrhose

C: Cancer du pancréas

D: Migration de calcul dans le cholédoque

E: Cholécystite

Un patient de 40 ans se présente pour du méléna. Son laboratoire montre: Hb 123 g/l, urée 24 mmol/l et créatinine 60 μ mol/l. Quel intervention est indiquée?

- A: Echographie rénale
- B: Scanner abdominal
- C: Rectoscopie rigide
- D: Gastroskopie
- E: Laparoscopie

Lors d'une cholécystectomie pour lithiase symptomatique, vous rencontrez des difficultés et vous convertissez pour une laparotomie. Vous avez coupé le canal hépatique droit. Que faites-vous?

- A: Hépatectomie droite
- B: Suture biliaire directe
- C: Mise en place de drains et transfert à une centre spécialisé
- D: Anastomose bilio-digestive
- E: Mise en place d'un drain de Kehr

Quel test est le plus sensible pour détecter un reflux gastro-oesophagien?

- A: Transit oeso-gastrique au baryum
- B: Manométrie
- C: Transit oeso-gastrique à la gastrographine
- D: Ph-métrie de 24 heures
- E: Oeso-gastroscoie

Un homme de 75 ans, traité par AINS pour une arthrite, se présente aux urgences avec un péritonisme abdominal et un pneumopéritoine visible au scanner. Les symptômes sont apparus il y a 6 heures, et ses signes vitaux sont stables après infusion d'un litre de NaCl 0.9%.

Quelle stratégie est adéquate?

A: Inhibiteurs de la pompe à proton, antibiotiques et laparoscopie d'emblée

B: Inhibiteurs de la pompe à proton, antibiotiques et laparotomie d'emblée

C: Inhibiteurs de la pompe à proton, antibiotiques et oeso-gastroscopie

D: Inhibiteurs de la pompe à proton, antibiotiques et opération si pas d'amélioration après 6 heures

Un homme de 55 ans présente une cirrhose sur hépatite C. Sa bilirubine: 100 $\mu\text{mol/l}$, créatinine: 110 $\mu\text{mol/l}$, INR: 1.9. Lors d'une échographie, une masse de 5 cm de diamètre avec prise de contraste précoce et wash-out tardif est mise en évidence dans le foie droit. L'alpha-foetoprotéine est de 80 $\mu\text{g/l}$.

Quel est le meilleur traitement?

- A: résection de la tumeur
- B: abstention thérapeutique
- C: transplantation du foie
- D: chimiothérapie par 5FU
- E: traitement par radiofréquence

Une patiente de 50 ans se présente à votre cabinet le lendemain d'une coloscopie de dépistage avec résection de polype. Elle décrit de violentes douleurs abdominales. Vous découvrez une défense de l'hémi-abdomen gauche. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A) Volvulus sigmoïdien
- B) Saignement du site de polypectomie
- C) Invagination intestinale
- D) Perforation intestinale
- E) Saignement splénique

Quelle intervention chirurgicale est indiquée en cas de découverte d'un adénocarcinome chez un patient avec une colite ulcéro-hémorragique?

- A) une procto-colectomie avec poche en J iléo-anale
- B) une résection sigmoïdienne
- C) une résection transanale
- D) une hémicolectomie gauche
- E) une amputation abdomino-périnéale du rectum

Quelle intervention chirurgicale est indiquée en cas d'adénome villositaire du rectum situé 4 à 6 cm de la marge anale ?

- A) Une procto-colectomie
- B) Une résection sigmoïdienne
- C) Une résection trans-anale
- D) Une radiothérapie locale
- E) Une amputation abdomino-périnéale du rectum

Un informaticien de 45 ans se présente aux urgences avec des douleurs en coup de poignard de la région épigastrique, persistantes depuis 4 heures. Il est fumeur et admet avoir présenté occasionnellement des douleurs du haut abdomen depuis plusieurs semaines. Une ultrasonographie abdominale effectuée récemment était sans particularité, ne montrant en particulier aucune évidence de cholélithiase. À l'examen clinique, vous constatez un abdomen aigu avec un péritonisme du haut abdomen et une absence de bruit. Dans ce contexte, quelle technique d'imagerie semble la plus utile?

- A) un ct scanner abdominal
- B) une radiographie du thorax de face couché
- C) une radiographie du thorax de face debout
- D) un transit baryté
- E) Répétition d'une ultrasonographie

Un homme de 89 ans vivant seul à domicile est hospitalisé suite à une chute qui a entraîné une fracture de hanche nécessitant une ostéosynthèse. Dans ses antécédents, on retrouve une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale chronique, et une carence en vitamine B 12 substituée. Vous constatez une cachexie importante (56 kg pour 180 cm). Le patient confirme une perte pondérale de 6 kg en 3 mois. Le laboratoire retrouve une anémie normocytaire normochrome à 10.8 g/dl (norme: 13.5-17.5) et une insuffisance rénale avec une clearance calculée à 32 ml/min (norme: >90). Le patient est opéré de sa hanche. Quelle est l'action la plus appropriée concernant ce patient?

- A) programmer une gastroscopie/colonoscopie
- B) introduire une alimentation parentérale
- C) introduire des suppléments alimentaires oraux
- D) prescrire du fer per os
- E) prescrire des suppléments de polyvitamines

Un homme de 60 ans présente un adénocarcinome du bas rectum découvert lors d'un CT scan abdominal. Quel est le meilleur traitement? sans lésion secondaire à distance. L'échographie endorectale montre une tumeur circonférentielle classée uT3N1 avec une marge circonférentielle < 1mm.

- A) proctectomie
- B) résection antérieure basse suivie d'une chimiothérapie à base de 5-FU
- C) mise en place d'une prothèse métallique endorectale
- D) radiothérapie avec chimiosensibilisation néo-adjuvante puis chirurgie
- E) chimiothérapie palliative

Bilan d'un cancer du rectum?

- A) colonoscopie et biopsies
- B) CT thoraco-abdominal
- C) IRM pelvienne
- D) Rectoscopie rigide
- E) Toutes ces réponses sont correctes

Une patiente de 72 ans est bien connue de votre hôpital en raison de ses lourds antécédents cardio-vasculaires: 2 pontages aorto-coronariens, un pontage aorto-bifémoral, un bypass fémoro-poplitée gauche, une amputation d'orteil à droite et une insuffisance rénale chronique. Elle se présente aux urgences avec une hématochézie importante et une instabilité hémodynamique. Qu'est ce qui est le plus probable?

- A) Une hémorragie sur colite ischémique
- B) Des varices oesophagiennes rompues
- C) Un anévrysme rompu de l'artère gastro-duodénale
- D) une fistule aorto-duodénale
- E) une ischémie mésentérique

Un homme de 65 ans consulte en raison de douleurs du bas abdomen. Vous trouvez une défense localisée en fosse iliaque gauche. Les globules blancs sont à 16,000. Le CT abdominal montre une infiltration de la graisse autour du colon sigmoïde, sans air ou liquide libre. Que proposez-vous?

- A) laparotomie avec colostomie latérale (sans résection)
- B) préparation colique en vue d'une coloscopie
- C) laparotomie avec résection sigmoïdienne
- D) opération selon Hartman
- E) traitement conservateur avec antibiotiques

Femme de 80 ans avec troubles du transit dans le cadre d'un Parkinson, présente de manière aiguë la présence d'une masse sortant de l'anus de la couleur d'une aubergine et douloureuse. Cela est apparu après un effort de défécation. Il s'agit:

- A. D'une tumeur
- B. D'un prolapsus rectal incarcerated
- C. D'une hémorroïde
- D. C'est normal et il n'y a rien à faire
- E. Une fissure anale

Une patiente de 82 ans se présente le matin aux urgences avec des douleurs en colique ayant débuté la nuit passée. Elle vomit 2x aux urgences. La patiente est afébrile, les leucocytes sont à 12'500, la CRP à 12. Vous effectuez un scanner qui met en évidence une intussusception iléo-colique. Qu'est ce qui est vrai pour cette patiente?

- A) Une résection colique est indiquée
- B) On peut espérer un traitement définitif avec un simple lavement
- C) La coloscopie sera probablement normale et permettra le traitement de l'intussusception dans le même temps
- D) Environ la moitié des patients présentant un tableau similaire guérissent spontanément
- E) Il ne s'agit jamais d'une tumeur à cet âge

Un homme de 26 ans se présente aux urgences avec des crampes abdominales diffuses récidivantes. L'examen physique met en évidence une masse abdominale palpable et une hyperpigmentation des lèvres, des paumes et des plantes de pied. A l'anamnèse familiale son père a eu une excision de polype plusieurs années auparavant. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A) Une polypose familiale avec dégénérescence maligne
- B) Un syndrome de Gardner avec intussusception
- C) Un syndrome de Peutz-Jeghers avec intussusception
- D) Une maladie de Crohn symptomatique
- E) Un gastrinome

Un jeune homme de 29 ans a une appendicectomie 4 jours auparavant pour une appendicite confirmée en per-opératoire. Le pathologue vous signale la présence d'une tumeur carcinoïde de 2.5 cm au sein de l'appendice, réséqué en totalité. Un CT ne montre pas de lésions ailleurs. Qu'est ce qui est juste pour ce patient?

- A) Une colectomie droite est indiquée
- B) Etant donné la taille, un syndrome carcinoïde est probable
- C) La localisation la plus fréquente des carcinoïdes est l'appendice
- D) Seule une surveillance par coloscopie tous les 2 ans est nécessaire
- E) Un complément de résection ne doit être effectué qu'en cas de résection incomplète ou de syndrome carcinoïde

Une femme de 28 ans présente des douleurs en FID d'apparition rapide. La douleur persiste et la patiente se présente aux urgences subfébrile, leucos 13'000, nausées. L'examen clinique met en évidence des douleurs en FID avec contracture musculaire et effet de masse. Un montre une image en cocarde. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A) Une appendicite aigue
- B) Un adénocarcinome caecal
- C) Un hématome du muscle grand droit
- D) Une torsion d'un kyste ovarien
- E) Une cholécystite

The GI Tract Is the Most Common Primary Location of NET (US SEER Data)

